Lista de Chequeo para la Atención de Código Azul en Gestantes

Ítem	Dato / Acción	Información
1	Nombre de la paciente	
2	Nº de historia clínica	
3	Edad / EG (semanas)	Edad: EG:
4	Fecha y hora del colapso (minuto 0)	____ / ____ / _____ Hora: _____
5	Tipo de Paciente	Obstétrica ☐ Ginecológica ☐ Postoperatoria ☐

Activación y Organización

Paso	Acción / Pregunta	Realizado Sí / No	Hora	Responsable (nombre y cargo)
1	Verifique: Inconsciente ☐ No respira ☐ Sin pulso ☐	☐ Sí ☐ No		
2	Se activó código azul indicando tipo de paciente (Postoperatorio, Ginecológica, Obstétrica).	☐ Sí ☐ No		
3	Se solicitó carro de paro, desfibrilador y equipo obstétrico/neonatal (si aplica)	☐ Sí ☐ No		
4	Se designó líder de reanimación.	☐ Sí ☐ No		Líder:
5	Se asignaron roles	☐ Sí ☐ No		Compresiones: Vía Aérea: Fármacos: Registro: Desplazamiento uterino:

RCP Básico

Paso	Acción / Pregunta	Realizado Sí / No	Hora inicio	Responsable
6	Inicio de compresiones torácicas (100–120/min, 5–6 cm de profundidad, mínima interrupción).	□ Sí □ No		
7	Paciente en superficie dura y en decúbito supino.	□ Sí □ No		
8	Desplazamiento uterino manual hacia la izquierda realizado de forma continua.	□ Sí □ No		
9	Ventilación con AMBÚ y O_2 al 100% según corresponda (30:2 o 1 cada 6 s si intubada).	□ Sí □ No		
10	Se retiraron monitores fetales para concentrarse en la madre. (si aplica)	□ Sí □ No		

Soporte Vital Avanzado

Recomendaciones

- Verificar ritmo cada 2 minutos con desfibrilador
- Considerar Cesárea Perimortem a los 4 minutos de RCP
- Intubación temprana por el más experto
- Alto riesgo de broncoaspiración

Paso	Acción	Si/No	Hora	Responsable	Observaciones
11	Monitorización de ritmo cardiaco y desfibrilador conectado.	□Sí □No			
12	Desfibrilación realizada según ritmo (FV/TV sin pulso).	□Sí □No			Energía: _____ J Nº descarga: _____

13	Vía Intravenosa/Intraósea establecida. (Por encima del nivel del diafragma)	□ Sí □ No			
14	Adrenalina 0,1 mg/kg cada 3–5 min (dosis estándar).	□ Sí □ No			Dosis por peso: ____ mg Dosis 1: hora ____ Dosis 2: hora ____ Dosis 3: hora ____
15	Amiodarona en Fibrilación Ventricular/ Taquicardia Ventricular refractaria (300 mg, luego 150 mg si precisa).	□ Sí □ No			300 mg: hora ____ 150 mg: hora ____
16	Se suspendió magnesio si estaba en infusión y se administró calcio si sospecha de toxicidad.	□ Sí □ No			Fármaco/dosis:

Causas Reversibles

Paso	Acción / Causa evaluada	Sí/No	Hora	Responsable	Observaciones
17	Evaluación de 4H: ● Hipoxia, ● Hipovolemia, ● Hipo-hiperpotasemia ● Hipotermia Evaluación 4T ● Tromboembolismo pulmonar ● Taponamiento, ● Neumotórax a tensión ● Tóxicos	□ Sí □ No			
18	Manejo de hemorragia obstétrica (masaje uterino, uterotónicos) si aplica.	□ Sí □ No			
19	Evaluación/manejo de TEP, embolia de líquido amniótico, otras causas.	□ Sí □ No			

Cesarea Perimortem

Paso	Acción / Pregunta	Sí/No	Hora	Responsable	Observaciones
20	Fondo uterino a nivel o por encima del ombligo (≥20–24 semanas) confirmado.	□ Sí □ No			
21	Ausencia de circulación espontánea tras 4 minutos de RCP efectiva documentada.	□ Sí □ No			
22	Se decidió e inició cesárea perimortem en el lugar de la RCP.	□ Sí □ No		Obstetra:	Hora de incisión: _____
23	Se continuaron compresiones y ventilación durante la cirugía.	□ Sí □ No			
24	Hora de nacimiento del recién nacido.	□ Sí □ No			
25	Equipo neonatal presente para recibir al recién nacido.	□ Sí □ No			
26	¿Se logró retorno de circulación espontánea?	□ Sí □ No			
27	Traslado a UCI para cuidados.	□ Sí □ No			
28	Cierre	□ Sí □ No		Revisión de toda la lista de chequeo y llenado de datos faltantes.	